Ministério do Planejamento e Orçamento
Secretaria de Assuntos Internacionais e Desenvolvimento - SEAID
Secretaria Executiva da COFIEX
Esplanada dos Ministérios – Bloco “K” – 8º Andar

CARTA CONSULTA

Qualificação do acesso e fortalecimento da rede de atenção às doenças crônicas não transmissíveis e saúde digital no estado de Alagoas

Nº Carta Consulta: 61067
Processo: 03101.102970/2023-01
Mutuário: Estado de Alagoas
Tipo de Operação: Operação de crédito externo
Data de Recebimento: 2 de Outubro de 2023

Fontes Internas:
Contrapartida Financeira: US$ 12.500.000,00
Fontes Externas:
Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD: US$ 50.000.000,00

Sumário

1. MARCO DE REFERÊNCIA 02
1.1. MARCO DE REFERÊNCIA/DIAGNÓSTICO 02
1.2. MARCO DE REFERÊNCIA/SOLUÇÃO PROPOSTA - RESULTADOS ESPERADOS - SUSTENTABILIDADE 02
1.3. MARCO DE REFERÊNCIA/ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS - CONTRAPARTIDA - TAXA DE CÂMBIO 04
2. PROJETO 04
2.1. TÍTULO 04
2.2. TÍTULO ABREVIADO 04
2.3. MUTUÁRIO 04
2.4. TIPO OPERACAO 04
2.5. PROJETO/OBJETIVO GERAL- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 04
2.6. PROJETO/INDICADORES 05
2.7. PROJETO/COMPONENTES 05
2.8. PROJETO/ETAPAS REALIZADAS 07
2.9. PROJETO/ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA 07
2.10. PROJETO/CONDIÇÕES FINANCEIRAS DA OPERAÇÃO 07
2.11. PROJETO/BENEFICIÁRIO 08
2.12. PROJETO/GARANTIA DA UNIÃO 08
3. FINANCIAMENTO 08
3.1. FINANCIAMENTO/FONTE 09
3.2. FINANCIAMENTO/INDICAÇÃO DE CONTRAGARANTIAS 09
4. EXECUÇÃO 09
4.1. EXECUÇÃO/ARRANJO INSTITUCIONAL- MATRIZ DE RESPONSABILIDADE- ARRANJO OPERACIONAL 09
4.2. EXECUÇÃO/EXECUTORES 09
4.3. EXECUÇÃO/PRAZO 10
4.4. EXECUÇÃO/CRONOGRAMA 10
5. RISCOS 11
5.1. RISCOS/ATOS LEGAIS 11
5.2. RISCOS/CONTRATAÇÕES 12
5.3. RISCOS/DESAPROPRIAÇÕES 12
5.4. RISCOS/IMPACTOS AMBIENTAIS 12
5.5. RISCOS/IMPACTO SOCIAL 12
5.6. RISCOS/REASSENTAMENTOS 12
5.7. RISCOS/INFORMAÇÕES FINANCEIRAS DO MUTUÁRIO DEVERÃO SER ENCAMINHADAS DIRETAMENTE À STN 12

1. Marco de Referência

1.1. MARCO DE REFERÊNCIA/DIAGNÓSTICO

1.1.1 Contexto geral do estado

Alagoas, um estado localizado no Nordeste do Brasil, com área de 27.843 km² e população estimada de 3,1 milhões de habitantes. É o segundo menor estado da região, atrás apenas de Sergipe. Sua população é predominantemente jovem, com 53,3% na faixa etária de 15 a 59 anos. A taxa de urbanização é de 73,6%, com 26,4% da população residindo na área rural. O estado apresenta indicadores socioeconômicos sensíveis, como: IDH de 0,684, o segundo menor do país; expectativa de vida de 69,87 anos, uma das mais baixa do país; alto índice de analfabetismo, com 19,4%; e grande desigualdade de renda, com o segundo pior rendimento médio per capita do país, de R$ 935.

Situação fiscal do Estado

Os ajustes fiscais implementados proporcionaram condições necessárias para que o Estado alcançasse solidez fiscal e financeira que permitiu melhorar sua classificação de risco para obtenção de crédito, aumentar sua capacidade de investimentos, ampliar a oferta de serviços públicos e valorizar seu quadro de servidores. Em 2022 foi observada uma mudança da trajetória desses resultados, evidenciando, por um lado, o aumento das despesas, especialmente do serviço da dívida e dos gastos com pessoal, e de outro, a queda da arrecadação decorrente notadamente dos impactos da Lei Complementar nº 194/2022 e do fim do ciclo de ingressos extraordinários.

A Dívida Consolidada Bruta (DC) do estado correspondia a 78,62% da Receita Corrente Líquida em 2022 (classificação B na CAPAG relativa a este indicador). Atualmente, o Governo do Estado processa uma operação de reestruturação e recomposição de principal de dívida estadual contraída com credores nacionais (Banco do Brasil S.A e Caixa Econômica Federal), de modo a assumir novo compromisso de linha de crédito com BIRD, em condições mais favoráveis e atingir melhor patamar de endividamento.

1.1.2 Contexto setorial e institucional: saúde

Perfil epidemiológico

As doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) constituem o principal problema de saúde pública em Alagoas, com altas taxas de morbimortalidade nos últimos anos (Anexo 1). O aumento da morbimortalidade por DCNT está relacionado a fatores como envelhecimento da população, transição demográfica e nutricional, e crescimento de fatores de risco modificáveis, como tabagismo, uso nocivo de álcool, inatividade física e alimentação não saudável e obesidade. As causas de óbitos mais frequentes em Alagoas são as relacionadas às DCNT, com destaque para doenças cardiovasculares, algumas doenças infecciosas e parasitárias e neoplasias. As doenças do aparelho circulatório são responsáveis pelas principais causas de óbitos no grupo das DCNTs em Alagoas. As neoplasias também tiveram aumento na carga de doença.

Organização do setor saúde e as novas tecnologias

Em Alagoas, o sistema de saúde ainda tem um longo caminho a percorrer quanto a necessidade de planejamento de médio e longo prazo, para o fortalecimento do sistema de saúde e articulação entre desenvolvimento e sustentabilidade. Faz-se necessário consolidar os processos que abranjam a demanda e oferta conscientes e racionais de serviços de saúde com utilização de tecnologias digitais, ferramentas essenciais para a melhoria da eficiência e da qualidade do atendimento em saúde. Os profissionais do setor de saúde precisam ser capacitados para utilizar essas tecnologias, que podem apoiar a tomada de decisão e melhorar o fluxo de trabalho. A inexistência de um programa de investimentos estruturado em tecnologias digitais é um entrave para o avanço na resposta aos principais desafios do setor saúde em Alagoas.

Rede de serviços de saúde e estrutura de gestão

A oferta de serviços de saúde em Alagoas está organizada em 2 macrorregiões e 10 regiões de saúde. Nos últimos anos, o estado tem realizado um esforço para ampliar e descentralizar os serviços de média e alta complexidade, no entanto, a expansão de unidades terciárias não foi acompanhada do aumento simultâneo da oferta de serviços especializados e de apoio diagnóstico. Apesar dos avanços, Alagoas ainda apresenta problemas relacionados à capacitação profissional, falta de tecnologias para serviços complexos, falta de informações para decisão; dificuldades de regulação assistencial à nova demanda; desequilíbrio entre oferta e demanda de diagnóstico, em alguns locais.

1.2. MARCO DE REFERÊNCIA/SOLUÇÃO PROPOSTA - RESULTADOS ESPERADOS - SUSTENTABILIDADE

1.2.1Área de abrangência do projeto

A área de abrangência do projeto engloba os 102 municípios do Estado, tendo como base a ampliação do acesso, maior eficiência e qualidade na cobertura e atendimento existentes para a operacionalização das linhas de cuidado priorizadas, correspondentes ao enfrentamento das principais causas de morbimortalidade do estado: (i) Linha de cuidado - Oncologia no adulto e (ii) Linha de cuidado - Doença Renal Crônica (DRC) dialítica em adultos. As áreas específicas de atuação e abrangência seguem as definições e critérios do Sistema Único de Saúde (SUS). Além de investimentos na (iii) assistência farmacêutica, (iv) aquisição de sistema gestão hospitalar e (v) consultorias externas e gestão do projeto.

1.2.2Detalhamento das propostas

(i)Linha de cuidado - Oncologia no Adulto: implementação de dois CACONs estaduais

A construção de Centros de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia (CACON) é uma medida fundamental para melhorar a qualidade de vida dos pacientes oncológicos em um estado que enfrenta sérios problemas de acesso e atendimento. CACON é uma unidade especializada que oferece serviços de prevenção, diagnóstico, tratamento, reabilitação e cuidados paliativos para pessoas com câncer, integrando as ações de atenção primária, secundária e terciária. Com a estruturação dos CACONs, os pacientes oncológicos poderiam receber um atendimento mais rápido, eficiente e humanizado, reduzindo as filas de espera, os deslocamentos, os custos e os riscos de complicações. Além disso, contribuiria para o desenvolvimento científico e tecnológico na área da oncologia, capacitando profissionais e gerando conhecimento. Portanto, a construção é uma prioridade para garantir o direito à saúde e à dignidade dos pacientes oncológicos em um estado que precisa urgentemente de mais recursos e estrutura para enfrentar essa grave doença. Do ponto de vista de sustentabilidade do projeto, o estado tem como norte a busca pela habilitação e incentivos para o futuro serviço, com vistas a utilizar o faturamento como ferramenta de sustentabilidade dos serviços. No mais, por utilizar estrutura hospitalar já existente, alguns custos serão minimizados pelo compartilhamento de serviços.

(ii)Linha de cuidado - Doença Renal Crônica dialítica em adultos: disponibilização de máquinas de diálise para descentralizar os serviços em hospitais regionais distantes da capital

A descentralização dos serviços de diálise ambulatorial é uma medida que visa melhorar a qualidade de vida e o acesso à saúde dos pacientes que sofrem de insuficiência renal crônica e que moram em municípios distantes dos grandes centros. Esses pacientes precisam realizar o procedimento de filtração do sangue periodicamente, o que demanda tempo, custo e desgaste físico e emocional para se deslocarem até as unidades especializadas. Ao oferecer o serviço de diálise ambulatorial dentro da estrutura hospitalar já existente nessas regiões, é possível reduzir os riscos de infecção, complicações e mortalidade, além de proporcionar maior conforto, autonomia e dignidade aos pacientes e seus familiares. A implantação deste serviço permitirá, ao estado, o faturamento de procedimentos até então realizados na rede suplementar; dessa forma, os proventos desses procedimentos serão o alicerce para sustentabilidade desta implementação.

(iii)Assistência farmacêutica: implementação de Sistema de Gerenciamento da Assistência Farmacêutica e expansão do programa Remédio em Casa

Um sistema de gerenciamento da assistência farmacêutica é uma ferramenta que permite otimizar os processos e recursos da assistência farmacêutica de um estado, garantindo a qualidade, a segurança e a eficiência na distribuição e no uso dos medicamentos. Entre as vantagens de implementar um sistema de gestão farmacêutica, é possível citar: (1) a melhoria do controle e do monitoramento do estoque, da validade e do consumo dos medicamentos, evitando desperdícios, faltas ou sobras; (2) a padronização dos critérios e dos procedimentos para a seleção, a aquisição, o armazenamento, a dispensação e a prescrição dos medicamentos, seguindo as diretrizes clínicas e as normas sanitárias vigentes; (3) a integração dos dados e das informações entre os diferentes níveis de atenção à saúde, facilitando o acompanhamento e a avaliação dos resultados terapêuticos e epidemiológicos; (4) a ampliação do acesso e da cobertura da assistência farmacêutica, especialmente para os pacientes que necessitam de medicamentos de alto custo ou de uso contínuo; (5) a expansão de um programa que fornece medicamento nos domicílios para os pacientes com condições crônicas de saúde, reduzindo os custos com transporte, as filas nas unidades de saúde ou de abandono do tratamento.

Um sistema de gerenciamento da assistência farmacêutica é, portanto, uma estratégia que contribui para a promoção da saúde, a prevenção de doenças e a melhoria da qualidade de vida da população. Além de contribuir com a redução de custos relacionados à perdas de medicações e insumos, bem como de compras emergenciais.

(iv)Sistema de gestão da rede hospitalar: aquisição de sistemas e equipamentos para implementação

Um sistema de gestão da rede hospitalar que integrará os equipamentos que compõem a rede hospitalar estadual com vistas a (1) melhorar a qualidade e a segurança do atendimento aos pacientes, pois os profissionais de saúde terão acesso rápido e fácil às informações clínicas, histórico, exames, medicamentos e alergias de cada paciente; (2) otimizar o uso dos recursos e reduzir custos, pois o sistema permitirá o controle e o monitoramento dos estoques, dos leitos, dos equipamentos e dos serviços prestados pelos estabelecimentos de saúde; (3) facilitar a gestão e a fiscalização dos hospitais, pois o sistema fornecerá dados e indicadores sobre o desempenho, a produtividade, a qualidade e a eficiência de cada unidade de saúde; (4) e promover a integração e a cooperação entre os hospitais e unidades pré-hospitalares.

(v)Consultorias externas, incentivos à educação e gestão do projeto:

Destaca-se a importância de consultorias externas para orientar e capacitar áreas estratégicas de saúde, auxiliando na identificação e resolução de problemas, bem como nas oportunidades existentes, através de evidências e boas práticas. Essas ações estarão em consonância com ações de educação para os profissionais de saúde. Por fim, com vias a garantir a devida execução do projeto, de acordo com a políticas de saúde do estado, será implementado uma equipe multidisciplinar para gestão do projeto.

1.3. MARCO DE REFERÊNCIA/ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS - CONTRAPARTIDA - TAXA DE CÂMBIO

O Projeto está integrado às orientações estratégicas globais do Estado, repercutidas nos programas prioritários definidos no Plano Plurianual (PPA) 2020-2023 e 2024-2027 (em preparação), e nas respectivas Leis Orçamentárias Anuais.

Os dados apresentados no diagnóstico evidenciam que o enfrentamento dos desafios postos ao estado implica em altos e crescentes custos com o manejo clínico e assistencial necessários à demanda de serviços de saúde e, dada a limitação de recursos para o seu financiamento, esta condição impõe ao estado a necessidade de investir cada vez mais em estratégias que preveem a introdução processos inovativos e incorporação de tecnologias de gestão, como forma de aumentar o acesso a serviços de saúde de qualidade e oportunos, de forma sustentável, transparente e que favoreça a consolidação do SUS.

O Estado, portanto, tem indicado nos seus instrumentos de planejamento estadual que a principal estratégia para o setor saúde continua sendo a expansão gradativa do modelo provisional de serviços públicos, com a implantação de sistemas integrados baseados em redes de atenção à saúde, e tendo como perspectiva a racionalidade e economicidade na oferta de serviços de saúde, diante da demanda crescente e apesar da limitação de recursos.

Considerando a possibilidade de financiamento externo e no sentido de potencializar as ações definidas no planejamento do Estado, definiu-se o conjunto de intervenções no Projeto, concentrado em intervenções de apoio à organização e consolidação do SUS, tendo como orientações estratégicas específicas:

- Ampliação do acesso às ações e serviços especializados de saúde para as linhas de cuidado priorizadas, com qualidade e de forma humanizada;

- Reorganização das práticas e dos processos de trabalhos para melhoria da qualidade da atenção à saúde;

- Desenvolvimento de tecnologias voltadas à sustentabilidade das unidades executoras das políticas de saúde, centralizadas e descentralizadas; e

- Fortalecimento dos processos de monitoramento efetivo das ações de prevenção e controle, identificação de grupos de risco, reconhecimento de casos para acionar intervenções e mensuração de tendências.

2. Projeto

2.1. Título

Qualificação do acesso e fortalecimento da rede de atenção às doenças crônicas não transmissíveis e saúde digital no estado de Alagoas

2.2. Título Abreviado

Alagoas Sem Parar

2.3. Mutuário

Estado de Alagoas

2.4. Tipo Operacao

Operação de crédito externo

2.5. PROJETO/OBJETIVO GERAL- OBJETIVOS ESPECÍFICOS

(i) Objetivo geral:

Melhorar o acesso, a eficiência e a qualidade do sistema estadual de atenção à saúde no âmbito das doenças crônicas não transmissíveis , assistência farmacêutica e integração dos sistemas de informação estaduais.

(ii) Objetivos específicos:

- Qualificar o cuidado longitudinal das condições crônicas oncológicas e de doença renal crônica com ampliação da cobertura de acompanhamento, estratificação de risco e monitoramento clínico-assistencial;

- Fortalecer a estrutura operacional de suporte da assistência farmacêutica estadual;

- Implantar e consolidar sistemas integrados de prontuário clínico e gestão hospitalar na rede de saúde do estado;

- Fortalecer a capacidade gerencial às equipes técnicas da Secretaria Estadual de Saúde através de consultorias externas, unidade de gestão do projeto e capacitação de servidores.

2.6. Projeto/Indicadores

Descrição	Fórmula de Cálculo	Unidade de Medida	Linha de Base	Meta
Resposta à demanda ? Câncer: Este indicador mensura o nível de resposta à demanda pelos serviços prestados dos CACONs estaduais	Tempo médio de espera para o paciente iniciar o tratamento.	Número de dias	90,00	45,00
Descentralização de atendimento de hemodiálise : Este indicador mensura a descentralização de atendimento, através do quantitativo de postos sob gestão estadual, beneficiando a população com atendimentos qualificados, céleres e com menor custo de transporte.	Mensuração quantitativa de postos de atendimento descentralizados sob gestão estadual	Nº postos estaduais	0,00	4,00
Sustentabilidade de compras farmacêuticas: Este indicador mensura os gastos com compras emergenciais devido às falhas no controle de estoque e planejamento de compras.	Volume financeiro de compras emergenciais para produtos farmacêuticos	% de compras emergenciais	11,50	5,00
Abrangência do Programa Remédio em Casa: Este indicador visa a quantificar os usuários beneficiados pelo programa.	Quantificação dos beneficiados pelo programa.	Nº absoluto beneficiários	9.000,00	18.000,00
Redução do quantitativo de perdas relacionadas às causas evitáveis na Central de Abastecimento , como vencimento do prazo de validade	Mensuração do valor perdido em medicamentos fora do prazo de validade na Central de Abastecimento	Valor em R$	1.500.000,00	500.000,00

2.7. Projeto/Componentes

Componentes	Valor(US$)
C - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO ÀS DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS COM ÊNFASE NA ONCOLOGIA E DOENÇA RENAL CRÔNICA	**43.200.000,00**
S - ESTRUTURAÇÃO FÍSICA E TECNOLÓGICA DE SERVIÇOS RELACIONADOS À ONCOLOGIA	36.000.000,00
P - Implantação de dois CACONs estaduais	36.000.000,00
S - DESCENTRALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HEMODIÁLISE AMBULATORIAL	7.200.000,00
P - Aquisição de equipamentos de hemodiálise	7.200.000,00
C - FORTALECIMENTO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	**2.400.000,00**
S - IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.400.000,00
P - Implementação de Sistema de Gerenciamento da Assistência Farmacêutica	1.800.000,00
P - Expansão do programa Remédio em Casa	600.000,00
C - AÇÕES DE EDUCAÇÃO E GESTÃO	**16.900.000,00**
S - IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO DA REDE DE SAÚDE	12.000.000,00
P - Implantação do sistema integrado de gestão da rede de saúde do estado	12.000.000,00
S - IMPLEMENTAÇÃO DE MEDIDAS DE CAPACITAÇÃO E MELHORIA NA TOMADA DE DECISÃO	2.400.000,00
P - Transferência de conhecimento para o fortalecimento na tomada de decisões estratégicas	2.400.000,00
S - GESTÃO DO PROJETO	2.500.000,00
P - Implementação de Unidade de Gestão do Projeto	2.500.000,00
Total dos Componentes	**62.500.000,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

Descrição detalhada dos componentes/subcomponentes e produtos:

C - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO ÀS DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS COM ÊNFASE NA ONCOLOGIA E DOENÇA RENAL CRÔNICA

Ações relacionadas à qualificação das doenças crônicas não transmissíveis, voltadas com maior ênfase para a oncologia e doença renal crônica dialítica

S - ESTRUTURAÇÃO FÍSICA E TECNOLÓGICA DE SERVIÇOS RELACIONADOS À ONCOLOGIA

Adaptação da infraestrutura existente e aquisição de equipamentos necessários para procedimentos cirúrgicos

P - Implantação de dois CACONs estaduais
Implementação de dois Centro de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia Estaduais nas estruturas existentes dos Hospitais Metropolitanos de Maceió e Arapiraca. Esses dois centros tem por objetivo ampliar os atendimentos de pacientes com câncer através de consultas, realização de exames e abordagens terapêuticas. Ao utilizar a estrutura existente nos hospitais metropolitanos, será possível compartilhar serviços e insumos, de maneira a mitigar os custos.

S - DESCENTRALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HEMODIÁLISE AMBULATORIAL
Distribuição de equipamentos de diálise ambulatorial em vazios assistenciais deste serviço no estado

P - Aquisição de equipamentos de hemodiálise
Realizar a aquisição de equipamentos de hemodiálise a fim de descentralizar os serviços de hemodiálise ambulatorial, utilizando a estrutura hospitalar já existente no estado. Essa proposta tem por objetivo aumentar a disponibilidade desse tipo de serviço na rede pública de saúde, bem como prover o acesso facilitado aos pacientes ao implementar centros em locais mais próximos de suas residências (centros descentralizados). No que tange a ampliação da rede hospitalar do estado, destacam-se os hospitais Regional da Mata (União dos Palmares-AL), Regional do Norte (Porto Calvo-AL) e Regional do Alto Sertão (Delmiro Gouveira-AL), cidades que, até então, não contam com serviço de hemodiálise ambulatorial disponível pelo SUS. Além desses, destaca-se o hospital Metropolitano de Alagoas (Maceió-AL).

C - FORTALECIMENTO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Ações para melhoria da eficiência e efetividade dos processos da assistência farmacêutica estadual

S - IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS
Aquisição de sistema de gerenciamento da assistência farmacêutica e aquisição de equipamentos para programa Remédio em Casa

P - Implementação de Sistema de Gerenciamento da Assistência Farmacêutica
A implementação do Sistema de Gerenciamento da Assistência Farmacêutica é uma ação transversal, com abrangência em diversas áreas. Planejamento de compras, organização de estoque e dispensação de medicações são alguns dos exemplos de atividades que podem ser melhoras com a implantação do sistema citado. A estruturação, através da aquisição de equipamentos, sistema e manutenção permitirá a minimização de perdas de insumos por causas evitáveis e redução de compras emergenciais. Além disso, o controle dos estoques nas unidades descentralizadas, sejam elas hospitalares ou CEAFs (Componente Especializado de Assistência Farmacêutica), dá informação e consequente subsídio à gestão para tomada de decisão mais assertiva no que tange melhorias logísticas e operativas.

P - Expansão do programa Remédio em Casa
Ampliação do programa Remédio em Casa que fornece medicamentos de maneira recorrente para pacientes com doenças crônicas abrangidas pelo programa. Essa ampliação se dará através da aquisição de equipamentos como capas de chuva, baús para motocicletas, baús refrigerados para transporte de termolábeis, capacete, roupas de identificação para os motociclistas, entre outros. Estima-se que o número de beneficiários atuais (cerca de 9.000) pode ser dobrado através de melhorias estruturais.

C - AÇÕES DE EDUCAÇÃO E GESTÃO
Ações voltadas para educação e apoio ao gerenciamento

S - IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO DA REDE DE SAÚDE
Aquisição e estruturação de sistema de gestão da rede de saúde

P - Implantação do sistema integrado de gestão da rede de saúde do estado
A implantação do sistema integrado de gestão tem por objetivo permitir melhorias na regulação da rede estadual de saúde, através do compartilhamento de informações e tomada de decisões assertivas, decorrente dos dados gerados pelos sistemas. A integração entre as informações de atendimentos hospitalares de pacientes pode contribuir para o acompanhamento adequado da saúde dos pacientes nos demais níveis de atenção à saúde.

S - IMPLEMENTAÇÃO DE MEDIDAS DE CAPACITAÇÃO E MELHORIA NA TOMADA DE DECISÃO
Implementação de medidas que visem a capacitação profissional e consubstanciem às áreas nas tomadas de decisão

P - Transferência de conhecimento para o fortalecimento na tomada de decisões estratégicas
Este produto tem por objetivo a contratação de consultorias externas especializadas para diagnóstico da rede e implementação de melhorias em áreas estratégicas, de maneira a aumentar a eficiência, eficácia e efetividade dos processos. Esse processo de melhorias estará em consonância com medidas de educação para os profissionais e servidores do estado, com a vias a melhorar e capacitar a assistência e qualificar a gestão.

S - GESTÃO DO PROJETO
Medidas para gestão do projeto

P - Implementação de Unidade de Gestão do Projeto
Implementação de Unidade de Gestão do Projeto para buscar a execução adequada, de acordo com os objetivos do projeto e orientações estratégicas voltadas à saúde do governo do estado, pautados na eficiência e transparência dos processos.

Categoria de Gasto	Unidade de medida	Meta	Valor	% Financeiro
Obras	-	-	**36.000.000,00**	**57,60**
P- Implantação de dois CACONs estaduais	Serviços de saúde	2,00	36.000.000,00	57,60
Bens	-	-	**21.600.000,00**	**34,56**
P- Aquisição de equipamentos de hemodiálise	Novos hospitais c serviço	3,00	7.200.000,00	11,52
P- Implementação de Sistema de Gerenciamento da Assistência Farmacêutica	Pessoas beneficiadas CEAF	70.000,00	1.800.000,00	2,88
P- Expansão do programa Remédio em Casa	Nº de beneficiários	18.000,00	600.000,00	0,96
P- Implantação do sistema integrado de gestão da rede de saúde do estado	% hospitais com sistema	100,00	12.000.000,00	19,20
Capacitação e Treinamento	-	-	**2.400.000,00**	**3,84**
P- Transferência de conhecimento para o fortalecimento na tomada de decisões estratégicas	Aumento % de capacitações	100,00	2.400.000,00	3,84
Outros	-	-	**2.500.000,00**	**4,00**
P- Implementação de Unidade de Gestão do Projeto	Quantidade	1,00	2.500.000,00	4,00
Total Geral	-	-	**62.500.000,00**	**100,00**

2.8. PROJETO/ETAPAS REALIZADAS

O estado de Alagoas já tem investido em programas de tratamento de doenças cardiovasculares, que são a principal causa de morte no Brasil. Dois exemplos desses programas são o AVC Dá Sinais e o Bate-Coração (Anexo 6).

O programa AVC Dá Sinais visa dar celeridade ao atendimento dos pacientes com suspeita ou diagnóstico de Acidente Vascular Cerebral (AVC), através da disponibilização de dispositivos eletrônicos (tablets) em unidades de saúde. O paciente com suspeita de AVC, atendido pelo SAMU, é inserido no sistema de telemedicina (Join), encaminhado para o hospital de referência para realização de tomografia de crânio e a partir do exame de imagem, a equipe de telemedicina (Telestroke) direciona o paciente para realização do tratamento trombolítico, cirúrgico ou conservador. Após cerca de 1 ano de implantação, o programa já realizou o atendimento de mais de 3.000 pacientes, dos quais 1.831 tiveram diagnóstico de AVC e foram realizados 238 trombólises venosas e 103 trombectomias mecânicas.

O programa Bate-Coração tem como objetivo reduzir a mortalidade por infarto agudo do miocárdio (IAM). O programa oferece um atendimento rápido e especializado aos pacientes que chegam às unidades de saúde com diagnóstico sugestivo, através do segmento do protocolo: chegada na unidade, realização da ECG, acionamento da equipe remota através da plataforma e encaminhamento para unidade de destino para tratamento.

Além disso, já conta com estudos técnicos preliminares que substanciam a necessidade da estruturação de serviços oncológicos (Anexo 2 e 3).

2.9. Projeto/Abrangência Geográfica

Abrangência Geográfica: Estadual/Sem detalhes

Estado de Alagoas ()

2.10. PROJETO/CONDIÇÕES FINANCEIRAS DA OPERAÇÃO

(i) Condições Financeiras

Moeda: USD

Valor: USD 50 milhões

Taxas de Juros: SOFR + 0,95% a.a.

Demais encargos e comissões: Taxa inicial de 0,25% do valor da operação, que é cobrada uma única vez, antes do desembolso. Além disso, há uma comissão de compromisso de 0,25% ao ano, cobrada sobre os valores não desembolsados e cujo período de cobrança se inicia 60 dias após a assinatura do acordo de empréstimo.

Período de amortização: semestral

Prazo de carência: 5 anos

Prazo total: 19 anos

É relevante destacar que as tais informações são preliminares e que as condições financeiras efetivas do empréstimo serão definidas nas negociações dos acordos. Tem-se ainda que as taxas mencionadas são as informadas no site do Banco Mundial no dia 29 de setembro de 2023.

Dado à agenda de transformação digital da política de estado implementada pelo Governo de Alagoas e a necessidade de melhorias substanciais no atendimento à saúde ao que se refere às doenças crónicas não transmissíveis que geram um volume oneroso de tratamentos quando há ocorrência de diagnósticos tardios, o financiamento se justifica pela urgente melhora deste serviços que possam trazer melhorias no bem estar social e gerar impactos econômicos expressivos, tanto nas conta públicas como na disponibilidade de renda da população assistida.

A escolha pelo Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento não se dá apenas pelas condições financeiras oferecidas serem mais competitivas e com menores custos que os demais órgãos financiadores, mas também pela estrutura de apoio técnico desempenhada em operação com grande impacto social.

Foram consideradas dois agentes financiadores para o Projeto Alagoas Sem Parar, o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD) e o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). As duas instituições selecionadas são órgãos financiadores externo por, para além da disponibilidade dos recursos financeiros, prestarem apoio à implementação dos projetos de investimento e proporcionar uma transferência de conhecimento através das consultorias durante a implementação e execução.

A nível de conhecimento, seguem as informações pertinentes para as condições financeiras inerentes aos empréstimos para investimento de capital.

A nível de taxa de juros, as duas instituições financeiras usam a SOFR + Spread Variável como taxa básica para ajuste. Porém, o BID acrescenta a taxa de Margem de Fundos de 0,41% que torna o pagamento de juros mais elevado.

As duas instituições possuem prazo de carência e desembolsos próximos, variando entre 3 e 6 anos. Quanto à taxa de compromisso sobre o valor não desembolsado, a simulação nos permitiu averiguar uma taxa de 0,25% sobre o saldo não desembolsado enquanto junto ao BID a mesma estaria pautada em 0,5% (podendo variar)

Portanto, considerando as condições financeiras e o apoio técnico especializado disponibilizado pelas duas instituições, fora selecionado o BIRD como instituição credora, levando ainda em consideração o bom relacionamento do Estado com tal instituição. Abaixo seguem condições acordadas previamente junto ao banco, mas que não são definitivas e podem ser ajustadas no decorrer das discussões para o contrato de empréstimo.

Valor do Projeto: US$ 62.500.000,00

Valor do Empréstimo: US$ 50.000.000,00

Valor da Contrapartida do Estado: US$ 12.500.000,00

Taxa de Juros: SOFR + Spread Variável (semestralmente)

Prazo de Desembolso: 60 meses

Prazo de Carência: até 66 meses

Prazo de Amortização: 162 meses

Prazo Total: 228 meses (19 anos)

2.11. PROJETO/BENEFICIÁRIO

População residente e não residente usuária dos serviços do SUS e profissionais da rede estadual de saúde. O programa estima como beneficiários os mais de 3 milhões de usuários ativos no Sistema Único de Saúde do Estado de Alagoas, acrescidos dos usuários eventuais do sistema de saúde suplementar e de outros estados do Brasil.

2.12. PROJETO/GARANTIA DA UNIÃO

Sim

3. Financiamento

3.1. Financiamento/Fonte

Moeda de Referência: Dólar

Fontes Internas	Sigla	Moeda	Valor Proposto	Taxa de Câmbio	Valor de Referência US $
Contrapartida Financeira	CF	US$	12.500.000,00	1,00	12.500.000,00
Fontes Externas	**Sigla**	**Moeda**	**Valor Proposto**	**Taxa de Câmbio**	**Valor de Referência US $**
Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD	BIRD	US$	50.000.000,00	1,00	50.000.000,00
Total:			62.500.000,00		62.500.000,00

3.2. FINANCIAMENTO/INDICAÇÃO DE CONTRAGARANTIAS

Concordo

4. Execução

4.1. EXECUÇÃO/ARRANJO INSTITUCIONAL- MATRIZ DE RESPONSABILIDADE- ARRANJO OPERACIONAL

(i) Arranjo institucional:

Seguem as instituições que participarão da implementação/execução do projeto proposto e prestar as informações ao BIRD.

- Secretaria de Estado da Saúde de Alagoas - SESAU

- Procuradoria Geral do Estado - PGE

- Agência de Modernização da Gestão de Processos - AMGESPA

Secretaria de Estado da Saúde de Alagoas (SESAU) é o órgão responsável pela gestão e execução das políticas de saúde pública do estado. Ela coordena e supervisiona as ações e os serviços de saúde, bem como os recursos financeiros destinados à área. Relacionado ao financiamento, a SESAU tem por responsabilidade investir em melhorias na saúde pública, como ampliação da rede de atenção, qualificação dos profissionais, aquisição de equipamentos e insumos, entre outros. Por fim, a secretaria é a responsável pela elaboração, implementação, monitoramento e avaliação do projeto de financiamento, em articulação com os demais órgãos e entidades envolvidos.

A Procuradoria Geral do Estado (PGE) é o órgão responsável por assessorar juridicamente o governo estadual e defender os seus interesses em todas as esferas. No âmbito de um projeto de financiamento que será realizado pela secretaria de saúde, a PGE tem o papel de analisar a legalidade e a viabilidade do contrato, bem como de acompanhar a execução e a prestação de contas dos recursos destinados à saúde pública do estado. A PGE também pode atuar na solução de eventuais conflitos ou demandas judiciais que envolvam o projeto.

A AMGESP (Agência de Modernização da Gestão de Processos) é o órgão responsável pelos processos licitatórios e de contratos do estado de Alagoas. Ela atua como gestora e fiscalizadora dos contratos administrativos, garantindo a legalidade, a eficiência e a transparência das contratações públicas. A AMGESP também auxiliará no projeto de financiamento que será realizado pela secretaria de saúde e que visará a aplicação de recursos na saúde pública do estado.

(ii) Matriz de Responsabilidades: Anexo 8.

(iii) Arranjo operacional:

As equipes da Secretaria de Estado da Saúde de Alagoas e demais órgãos do governo encontram-se engajados para desenvolver as propostas com toda celeridade possível. No que tange as políticas de aquisições previstas, estas passam por uma criteriosa análise da viabilidade e adequação aos regulamentos do Banco Mundial. Sabe-se que requisitos deverão ser atendidos para que as aquisições sejam consideradas elegíveis.

No que tange as salvaguardas, existem cláusulas especificas no contrato que deverão ser cumpridos seja elas em salvaguardas sociais, sejam elas ambientais. Preza-se pela sustentabilidade e adequação das ações para garantir a segurança das ações propostas.

4.2. Execução/Executores

Executor: Governo do Estado de Alagoas
Representante Oficial: Paulo Suruagy do Amaral Dantas
Endereço da Sede: Palácio República dos Palmares, R. Cincinato Pinto S/N- 2º Andar ,Centro
E-mail Institucional:
Telefone: 8233152002 Fax:
CNPJ: UF:

4.3. Execução/Prazo

Prazo de Desembolso: 5 **Anos**

4.4. Execução/Cronograma

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 1 FONTES CF	Ano 1 FONTES BIRD	TOTAL CF	TOTAL BIRD
C - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO ÀS DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS COM ÊNFASE NA ONCOLOGIA E DOENÇA RENAL CRÔNICA	**43.200.000,00**	**1.190.000,00**	**5.760.000,00**		
S - ESTRUTURAÇÃO FÍSICA E TECNOLÓGICA DE SERVIÇOS RELACIONADOS À ONCOLOGIA	36.000.000,00	1.000.000,00	5.000.000,00		
P - Implantação de dois CACONs estaduais	36.000.000,00	1.000.000,00	5.000.000,00		
S - DESCENTRALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HEMODIÁLISE AMBULATORIAL	7.200.000,00	190.000,00	760.000,00		
P - Aquisição de equipamentos de hemodiálise	7.200.000,00	190.000,00	760.000,00		
C - FORTALECIMENTO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	**2.400.000,00**	**70.000,00**	**330.000,00**		
S - IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.400.000,00	70.000,00	330.000,00		
P - Implementação de Sistema de Gerenciamento da Assistência Farmacêutica	1.800.000,00	50.000,00	250.000,00		
P - Expansão do programa Remédio em Casa	600.000,00	20.000,00	80.000,00		
C - AÇÕES DE EDUCAÇÃO E GESTÃO	**16.900.000,00**	**980.000,00**	**3.920.000,00**		
S - IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO DA REDE DE SAÚDE	12.000.000,00	800.000,00	3.200.000,00		
P - Implantação do sistema integrado de gestão da rede de saúde do estado	12.000.000,00	800.000,00	3.200.000,00		
S - IMPLEMENTAÇÃO DE MEDIDAS DE CAPACITAÇÃO E MELHORIA NA TOMADA DE DECISÃO	2.400.000,00	80.000,00	320.000,00		
P - Transferência de conhecimento para o fortalecimento na tomada de decisões estratégicas	2.400.000,00	80.000,00	320.000,00		
S - GESTÃO DO PROJETO	2.500.000,00	100.000,00	400.000,00		
P - Implementação de Unidade de Gestão do Projeto	2.500.000,00	100.000,00	400.000,00		
Total	**0,00**	**2.240.000,00**	**10.010.000,00**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 2 FONTES CF	Ano 2 FONTES BIRD	TOTAL CF	TOTAL BIRD
C - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO ÀS DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS COM ÊNFASE NA ONCOLOGIA E DOENÇA RENAL CRÔNICA		**2.950.000,00**	**11.800.000,00**		
S - ESTRUTURAÇÃO FÍSICA E TECNOLÓGICA DE SERVIÇOS RELACIONADOS À ONCOLOGIA		2.500.000,00	10.000.000,00		
P - Implantação de dois CACONs estaduais		2.500.000,00	10.000.000,00		
S - DESCENTRALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HEMODIÁLISE AMBULATORIAL		450.000,00	1.800.000,00		
P - Aquisição de equipamentos de hemodiálise		450.000,00	1.800.000,00		
C - FORTALECIMENTO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		**150.000,00**	**610.000,00**		
S - IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		150.000,00	610.000,00		
P - Implementação de Sistema de Gerenciamento da Assistência Farmacêutica		120.000,00	500.000,00		
P - Expansão do programa Remédio em Casa		30.000,00	110.000,00		
C - AÇÕES DE EDUCAÇÃO E GESTÃO		**800.000,00**	**3.600.000,00**		
S - IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO DA REDE DE SAÚDE		600.000,00	2.800.000,00		
P - Implantação do sistema integrado de gestão da rede de saúde do estado		600.000,00	2.800.000,00		
S - IMPLEMENTAÇÃO DE MEDIDAS DE CAPACITAÇÃO E MELHORIA NA TOMADA DE DECISÃO		100.000,00	400.000,00		
P - Transferência de conhecimento para o fortalecimento na tomada de decisões estratégicas		100.000,00	400.000,00		
S - GESTÃO DO PROJETO		100.000,00	400.000,00		
P - Implementação de Unidade de Gestão do Projeto		100.000,00	400.000,00		
Total	**0,00**	**3.900.000,00**	**16.010.000,00**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 3 FONTES CF	Ano 3 FONTES BIRD	TOTAL CF	TOTAL BIRD
C - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO ÀS DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS COM ÊNFASE NA ONCOLOGIA E DOENÇA RENAL CRÔNICA		**2.350.000,00**	**9.500.000,00**		
S - ESTRUTURAÇÃO FÍSICA E TECNOLÓGICA DE SERVIÇOS RELACIONADOS À ONCOLOGIA		2.000.000,00	8.000.000,00		
P - Implantação de dois CACONs estaduais		2.000.000,00	8.000.000,00		
S - DESCENTRALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HEMODIÁLISE AMBULATORIAL		350.000,00	1.500.000,00		
P - Aquisição de equipamentos de hemodiálise		350.000,00	1.500.000,00		
C - FORTALECIMENTO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		**130.000,00**	**500.000,00**		

S - IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		130.000,00	500.000,00		
P - Implementação de Sistema de Gerenciamento da Assistência Farmacêutica		90.000,00	350.000,00		
P - Expansão do programa Remédio em Casa		40.000,00	150.000,00		
C - AÇÕES DE EDUCAÇÃO E GESTÃO		**650.000,00**	**2.800.000,00**		
S - IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO DA REDE DE SAÚDE		450.000,00	2.000.000,00		
P - Implantação do sistema integrado de gestão da rede de saúde do estado		450.000,00	2.000.000,00		
S - IMPLEMENTAÇÃO DE MEDIDAS DE CAPACITAÇÃO E MELHORIA NA TOMADA DE DECISÃO		100.000,00	400.000,00		
P - Transferência de conhecimento para o fortalecimento na tomada de decisões estratégicas		100.000,00	400.000,00		
S - GESTÃO DO PROJETO		100.000,00	400.000,00		
P - Implementação de Unidade de Gestão do Projeto		100.000,00	400.000,00		
Total	**0,00**	**3.130.000,00**	**12.800.000,00**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 4 FONTES CF	Ano 4 FONTES BIRD	TOTAL CF	TOTAL BIRD
C - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO ÀS DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS COM ÊNFASE NA ONCOLOGIA E DOENÇA RENAL CRÔNICA		**1.300.000,00**	**5.000.000,00**		
S - ESTRUTURAÇÃO FÍSICA E TECNOLÓGICA DE SERVIÇOS RELACIONADOS À ONCOLOGIA		1.000.000,00	4.000.000,00		
P - Implantação de dois CACONs estaduais		1.000.000,00	4.000.000,00		
S - DESCENTRALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HEMODIÁLISE AMBULATORIAL		300.000,00	1.000.000,00		
P - Aquisição de equipamentos de hemodiálise		300.000,00	1.000.000,00		
C - FORTALECIMENTO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		**80.000,00**	**320.000,00**		
S - IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		80.000,00	320.000,00		
P - Implementação de Sistema de Gerenciamento da Assistência Farmacêutica		60.000,00	240.000,00		
P - Expansão do programa Remédio em Casa		20.000,00	80.000,00		
C - AÇÕES DE EDUCAÇÃO E GESTÃO		**550.000,00**	**1.800.000,00**		
S - IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO DA REDE DE SAÚDE		350.000,00	1.000.000,00		
P - Implantação do sistema integrado de gestão da rede de saúde do estado		350.000,00	1.000.000,00		
S - IMPLEMENTAÇÃO DE MEDIDAS DE CAPACITAÇÃO E MELHORIA NA TOMADA DE DECISÃO		100.000,00	400.000,00		
P - Transferência de conhecimento para o fortalecimento na tomada de decisões estratégicas		100.000,00	400.000,00		
S - GESTÃO DO PROJETO		100.000,00	400.000,00		
P - Implementação de Unidade de Gestão do Projeto		100.000,00	400.000,00		
Total	**0,00**	**1.930.000,00**	**7.120.000,00**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 5 FONTES CF	Ano 5 FONTES BIRD	TOTAL CF	TOTAL BIRD
C - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO ÀS DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS COM ÊNFASE NA ONCOLOGIA E DOENÇA RENAL CRÔNICA		**850.000,00**	**2.500.000,00**	**8.640.000,00**	**34.560.000,00**
S - ESTRUTURAÇÃO FÍSICA E TECNOLÓGICA DE SERVIÇOS RELACIONADOS À ONCOLOGIA		700.000,00	1.800.000,00	7.200.000,00	28.800.000,00
P - Implantação de dois CACONs estaduais		700.000,00	1.800.000,00	7.200.000,00	28.800.000,00
S - DESCENTRALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HEMODIÁLISE AMBULATORIAL		150.000,00	700.000,00	1.440.000,00	5.760.000,00
P - Aquisição de equipamentos de hemodiálise		150.000,00	700.000,00	1.440.000,00	5.760.000,00
C - FORTALECIMENTO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		**50.000,00**	**160.000,00**	**480.000,00**	**1.920.000,00**
S - IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		50.000,00	160.000,00	480.000,00	1.920.000,00
P - Implementação de Sistema de Gerenciamento da Assistência Farmacêutica		40.000,00	100.000,00	360.000,00	1.440.000,00
P - Expansão do programa Remédio em Casa		10.000,00	60.000,00	120.000,00	480.000,00
C - AÇÕES DE EDUCAÇÃO E GESTÃO		**400.000,00**	**1.400.000,00**	**3.380.000,00**	**13.520.000,00**
S - IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO DA REDE DE SAÚDE		200.000,00	600.000,00	2.400.000,00	9.600.000,00
P - Implantação do sistema integrado de gestão da rede de saúde do estado		200.000,00	600.000,00	2.400.000,00	9.600.000,00
S - IMPLEMENTAÇÃO DE MEDIDAS DE CAPACITAÇÃO E MELHORIA NA TOMADA DE DECISÃO		100.000,00	400.000,00	480.000,00	1.920.000,00
P - Transferência de conhecimento para o fortalecimento na tomada de decisões estratégicas		100.000,00	400.000,00	480.000,00	1.920.000,00
S - GESTÃO DO PROJETO		100.000,00	400.000,00	500.000,00	2.000.000,00
P - Implementação de Unidade de Gestão do Projeto		100.000,00	400.000,00	500.000,00	2.000.000,00
Total	**62.500.000,00**	**1.300.000,00**	**4.060.000,00**	**12.500.000,00**	**50.000.000,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

5. Riscos

5.1. RISCOS/ATOS LEGAIS

Nesse projeto setorial de abordagem assistencial, com base em políticas públicas consolidadas da saúde (SUS), não estão previstos ônus resultantes das intervenções previstas que possam afetar negativamente as instituições e órgãos participantes, nem a saúde, a segurança e o bem-estar da população alvo. Os atos que estejam diretamente ou indiretamente associados às ações do Projeto obedecerão aos ritos legais e administrativos previstos no planejamento estratégico do Governo e compatibilizados com as diretrizes das políticas e programas públicos de saúde apoiados. No que tange os riscos de gargalos do projeto, no que tange as tramitações legais, licitações ou autorizações, a Agência de Modernização de Processos de Alagoas (AMGESP) e Procuradoria Geral do Estado de Alagoas (PGE) estão em sintonia com os projetos que serão desenvolvidos a fim de mitigar eventuais atrasos burocráticos.

As atividades de assistência técnica do Projeto seguirão as diretrizes de aquisição e seleção de consultoria do Banco Mundial. As demais intervenções seguirão as diretrizes da Lei Federal 8.666/1993 e atualizações, em concordância com o Banco Mundial. Atos legais complementares serão publicados oportunamente abrangendo a Lei Autorizativa do Projeto, Decreto de criação da Unidade de Gerenciamento do Projeto e previsão do Projeto nos instrumentos governamentais de planejamento (PPA, LDO e LOA).

5.2. RISCOS/CONTRATAÇÕES

O Projeto prevê uma grande quantidade de contratações durante a sua implementação abrangendo a aquisição de bens, contratação de serviços, obras e consultorias. Para isso, contará com uma equipe com experiência em licitações com regramento internacional adquirida ao longo da implementação de Projetos semelhantes. Para sanar as dificuldades que possam ser geradas pela quantidade de órgãos envolvidos, seja no âmbito das aquisições, seja no âmbito das salvaguardas sociais e ambientais, o Estado irá centralizar suas licitações na UGP que estará implantada na SEFAZ, sendo formada uma equipe exclusivamente para este fim.

Serão atendidos todos os requisitos legais vigentes, incluindo o cumprimento do Plano Plurianual (PPA), Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), Lei Orçamentária Anual (LOA), Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), bem como toda a legislação administrativa, financeira e fiscal suplementar. Será necessária uma Lei Autorizativa do Estado para o programa e um Decreto Regulamentador, cujas tramitações serão iniciadas assim que a carta consulta for aprovada.

Além disso, serão formalizados instrumentos específicos para as intervenções a serem desenvolvidas no âmbito do Projeto, como a celebração de contratos administrativos, termos de outorgas, convênios ou instrumentos congêneres, de acordo com a legislação vigente, que determinará as particularidades e requisitos a serem atendidos em cada ocasião.

5.3. RISCOS/DESAPROPRIAÇÕES

Tendo por base as intervenções propostas no escopo do Projeto, não estão previstas desapropriações de nenhuma modalidade. As áreas de atuação ou beneficiárias do Projeto são de propriedade do Estado, com situação fundiária regularizada não requerendo, portanto, desapropriações.

5.4. RISCOS/IMPACTOS AMBIENTAIS

Pela natureza das ações previstas no escopo do Projeto não há previsão de prejuízos ambientais provocados diretamente pela execução de suas intervenções. Considerando a necessidade de execução de reformas e/ou ampliações de espaços físicos no decorrer do Projeto, identificam-se riscos baixos no processo de execução das obras, bem como no descarte do material delas decorrentes. Entretanto, será discutida e acordada com o Banco Mundial a matriz de acompanhamento, antecipação e mitigação de tais riscos durante a preparação do Projeto.

Ademais, o Estado de Alagoas se compromete em seguir as determinações da legislação ambiental definidas tanto na esfera nacional como estadual e, ainda, respeitar as recomendações do Quadro Ambiental e Social do Banco Mundial. Em momento oportuno, antes de declarada a efetividade do Projeto, por determinação do já citado Quadro Ambiental e Social do agente financiador do Projeto, será elaborado o documento específico de Salvaguardas Ambientais onde estarão esclarecidas as etapas de execução das intervenções e os compromissos do Estado para evitar, minimizar e mitigar possíveis impactos ambientais negativos.

5.5. RISCOS/IMPACTO SOCIAL

A observação do escopo do projeto evidencia que nenhuma intervenção impactará negativamente sob quaisquer aspectos grupos sociais fragilizados, como as populações indígenas, os quilombolas ou comunidades tradicionais. Porém, esses grupos populacionais, assim como outras categorias sociais como idosos e mulheres, comporão o rol de beneficiários diretos e indiretos das ações do Projeto. Mesmo diante dessa perspectiva, em momento oportuno, antes de declarada a efetividade do Projeto, em conformidade com o Quadro Ambiental e Social do Banco Mundial, será elaborado o documento de avaliação social do Projeto, no qual serão descritos os detalhes de implementação das intervenções e como cada uma delas impactará as categorias ou grupos sociais identificados. Se for identificado risco de impacto social negativo será apontado no documento os compromissos do Estado para a prevenção, mitigação ou compensação em cada uma das situações identificadas.

5.6. RISCOS/REASSENTAMENTOS

Tendo por base as intervenções propostas no escopo do Projeto, não estão previstos reassentamentos.

5.7. RISCOS/INFORMAÇÕES FINANCEIRAS DO MUTUÁRIO DEVERÃO SER ENCAMINHADAS DIRETAMENTE À STN